

## POE SEGUIMIENTO DEL CONTROL DEL INR EN ATENCION PRIMARIA

Fecha entrada en vigor: 01/06/2021

### PAUTA DE AJUSTE PARA PACIENTES CON INR FUERA DE RANGO

| Manejo de INR fuera de rango 2-3<br>TAO con acenocumarol (Sintrom®) |                                                                                                                                                                  | Manejo de INR fuera de rango 2.5-3.5 (prótesis metálicas)<br>TAO con acenocumarol (Sintrom®) |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situación clínica                                                   | Pauta                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| INR<1.4                                                             | Aumento de dosis de 10-20% (aproximadamente 1-2 mg/semana) y HBPM (dosis terapéuticas) si riesgo elevado de trombosis hasta INR en rango.<br>Control a la semana | INR<1.8                                                                                      | Aumento de dosis 10-20% (aproximadamente 1-2 mg/semana) y HBPM si riesgo elevado de trombosis hasta INR en rango.<br>Control a la semana                                       |
| INR 1.4-1.6                                                         | Aumento de dosis 5-10% (aproximadamente 1 mg/semana).<br>Control a la semana                                                                                     | INR 1.9-2.3                                                                                  | Aumento de dosis 10-20% (aproximadamente 1-2 mg/semana).<br>Control a la semana                                                                                                |
| INR 1.7-2<br>INR 3-3.4                                              | Mantener dosis.<br>Considerar en rango o adelantar siguiente control.                                                                                            | INR 2.4-2.5<br>INR 3.5-3.8                                                                   | Sin cambios en la dosis.<br>Adelantar siguiente control.                                                                                                                       |
| INR 3.5-4.9                                                         | Reducir dosis semanal en 10-20% (aproximadamente 1-2 mg) omitiendo la dosis de ese día.<br>Control a la semana                                                   | INR 3.9-4.9                                                                                  | Reducir dosis semanal en 10-20% (aproximadamente 1-2 mg) omitiendo la dosis de ese día si INR próximo a 5 y riesgo de hemorragia. Control a la semana.                         |
| INR≥5**                                                             | Interrumpir TAO y administrar 2 mg de vit K (Konakion®).<br>Control al tercer día. Reanudar TAO cuando INR<5 reduciendo DTS última 1mg y control a la semana.    | INR ≥5                                                                                       | Interrumpir TAO. Control al 3º día. Si sangrado o riesgo aumentado de hemorragia, administrar 2 mg de vit K (Konakion®). Reanudar TAO cuando INR<5 reduciendo DTS última 1 mg. |

Los enfermeros sólo podrán actuar por encima de valores de INR  $\geq 1.4$  (para rango terapéutico de INR 2-3) o INR  $\geq 2$  (para rango terapéutico de 2.5 – 3.5) y hasta valores de INR  $\leq 5$ . En el resto de los casos se tendrán que informar al MAP para que sea este el que lo valore.

Si los valores de INR  $\geq 5$  se repiten en varias ocasiones (3 determinaciones consecutivas), se podrá contactar con Hematología (vía telefónica) para valorar derivación.

## **RECOMENDACIONES GENERALES**

- Como pauta orientativa estándar, el INR se debe mantener entre 2-3 en fibrilación auricular, tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y cardiopatías valvulares. Entre 2.5-3.5 en portadores de prótesis valvulares metálicas y en ciertos pacientes de alto riesgo trombótico (serán definidos por hematología). Cada paciente tendrá unos valores de rango de INR según sus condiciones particulares.
- Los pacientes en rango terapéutico por lo general se citarán cada 5 ó 6 semanas como máximo y con anterioridad si hay que realizar alguna modificación.
- Todo paciente que comience su control en atención primaria será visto en consulta de enfermería, donde se hará una valoración enfermera por necesidades básicas, llegando a un diagnóstico de enfermería y la posterior puesta en marcha de un plan de cuidados expresado en taxonomía NANDA-NIC-NOC. Todo este procedimiento a seguir se encuentra detallado en el anexo AX02-POE-ACO-DSCorGu-001-V2.
- Igualmente se debe realizar un plan de recomendaciones generales y otras específicas para mejorar la calidad de vida del paciente anticoagulado que se encuentran detalladas en el correspondiente anexo AX03-POE-ACO-DSCorGu-001-V2.
- Todos los controles realizados a los pacientes anticoagulados así como todas las intervenciones que se realicen deben quedar registrados en su historia digital.

### **CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA (derivar al paciente al MAP)**

|                                                                                                   |                     |                            |                            |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio clínico del paciente relacionado con contraindicación del uso de acenocumarol o warfarina. | Fin del tratamiento | Cáncer                     | Intervenciones quirúrgicas | Inicio de tratamiento con dosis altas de AINES, miconazol, fenilbutazona, ácido acetil salicílico, salicilato |
| Hospitalización.                                                                                  | Embarazo.           | Úlceras gastrointestinales | Hipertensión grave         |                                                                                                               |

### **Otros datos de interés**

- Para resolución de problemas con el programa de coagulación GOTA® se podrá contactar en el siguiente teléfono: Helpline: 900813366 o en su defecto con el informático de GOTA®: 625154703.
- UGC de Hematología. Tlfns. de contacto: 510202, 510129 y 757289.

El acceso al documento completo y los anexos del POE de Seguimiento de INR del Distrito se encuentra en el Portal de Farmacia/ Documentos de interés/Guías/Manuales